

Question #1

PASIEN LAKI-LAKI 19 TH DENGAN TRAUMA MATA KIRI.

A. DESKRIPSIKAN KELAINAN

B. APA DIAGNOSIS SAUDARA

Answer :

Teknik: CT scan sinus paranasal tanpa kontras intravena, potongan coronal.

Deskripsi:

Fraktur di orbital floor kiri dengan depresi inferior ke intrasinus maksilaris kiri.

Perselubungan berdensitas perdarahan di intrasinus maksilaris kiri.

Kesimpulan:

Fraktur orbital floor kiri disertai hematosinus maksilaris kiri.

Question #2

Perempuan, 56 tahun, dengan nyeri kepala berat dan paraparesis mendadak.

1) Deskripsikan

2) Diagnosis dan diagnosis banding

Answer :

Teknik: CT scan kepala non kontras potongan sagittal.

Deskripsi:

Tampak lesi hiperdens berdensitas perdarahan di regio retroclival disertai multipel fraktur pada os odontoid dan clivus.

Tampak kalsifikasi di intravena of Galen.

Kesimpulan:

- Fraktur pada os odontoid dan clivus disertai perdarahan di regio retroclival.
- Trombus pada vein of Galen.

Subject : Ujian_Juni_2026a_HER

Instructor : Ujian Semester 3

Corrector : EMERGENCY

Student ID : 21

Question #3

Laki-laki 41 tahun dengan kelemahan sisi kanan sejak 3 jam yang lalu

- a. Deskripsikan kelainan dan tanda-tanda radiologis yang tervisualisasi!
- b. Sebutkan diagnosis radiologis pada pemeriksaan ini!

Answer :

Teknik: CT angiografi kepala dengan kontras intravena, potongan aksial dan coronal.

Deskripsi:

Tampak hyperdense vessel sign pada arteri cerebri media kiri segmen M1.

CTA:

Arteri cerebri media kiri dan cabang-cabangnya tidak tervisualisasi.

Kesimpulan:

- Infark akut pada regio arteri cerebri media kiri.
- CTA: Stenosis pada arteri cerebri media kiri segmen M1.

Question #4

- a. Pemeriksaan apakah ini?
- b. Deskripsikan kelainan yang anda lihat!
- c. Apa diagnosis kerja anda?

Answer :

Teknik: Pemeriksaan esofagomaagduodenografi dengan kontras oral water soluble.

Deskripsi:

Tampak kontras mengisi esofagus, lambung hingga duodenum.

Tampak filling defect di duodenum pars D2 dengan multipel outpouching.

Kesimpulan:

Sesuai gambaran divertikulum duodenum.

Question #5

PASIEN DENGAN IKTERUS.

- a. Pemeriksaan apakah ini?
- b. Deskripsikan kelainan yang anda lihat!
- c. Apa diagnosis kerja anda?

Answer :

Teknik: Kolangiografi PTBD kontras water soluble.

Deskripsi:

Terpasang catheter PTBD dengan tip di intra CBD.

Tampak kontras mengisi duktus intrahepatika kanan dan kiri serta cabang-cabang distalnya, duktus ekstrahepatik, CBD hingga ampulla Vateri.

Kontras tidak tampak jelas mengisi duodenum.

Tampak lesi filling defect radioopak di CBD distal yang menyebabkan dilatasi pada segmen

proksimalnya.

Tidak tampak stenosis pada saluran biliar.

Kesimpulan:

Batu CBD distal yang menyebabkan dilatasi CBD segmen proksimalnya.

Question #6

Anak perempuan 1 tahun dengan ISK berulang

Sebutkan:

- nama pemeriksaan
- Temuan
- Diagnosis dan diagnosis banding bila ada

Answer :

Teknik: Sistografi retrograde dengan kontras water soluble.

Deskripsi:

Terpasang folley catheter melalui uretra.

Tampak kontras lancar mengisi vesica urinaria.

Tampak aliran kontras ke abdomen regio umbilical.

Kesimpulan:

Sesuai gambaran patent ductus urachus

Question #7

An 1 tahun berat badan tidak naik.

Sebutkan

- Nama pemeriksaan
- Temuan
- Diagnosis dan diagnosis banding bila ada

Answer :

Teknik: Radiografi toraks proyeksi AP dan lateral.

Deskripsi:

Jantung kesan tidak membesar.

Aorta baik.

Mediastinum superior melebar ke kanan (vaskular).

Trakhea di relatif tengah. Kedua hilus tidak menebal.

Multipel opasitas miliar di seluruh lapang kedua paru.

Konsolidasi dengan air bronchogram di lapangan bawah paru kanan.

Tulang-tulang baik.

Kesimpulan:

Sesuai gambaran TBC paru miliar, DD/ pneumonia.

Question #8

Pasien perempuan 43 tahun dengan nyeri dan kaku punggung. Deskripsikan kelainan yang terlihat serta sebutkan diagnosis dan diagnosis bandingnya.

Answer :

Teknik: Radiografi vertebra torakolumbal proyeksi AP dan lateral.

Deskripsi:

Lengkung kifotik vertebra torakal bertambah, dan lengkung lordosis vertebra lumbal kesan masih baik.

Tidak tampak listesis maupun lateralisasi.

Tidak tampak fraktur maupun dislokasi.

Formasi sindesmofit continuous pada vertebra torakal dengan gambaran bamboo spine.

Celah diskus intervertebralis tidak menyempit.

Sendi sakroiliaka bilateral tampak fusi.

Sendi facet masih baik.

Jaringan lunak tidak menebal.

Kesimpulan:

- Ankylosing spondylitis vertebra torakal, dengan fusi sendi sakroiliaka bilateral, dapat sesuai gambaran SpA aksial.

Question #9

Anak berusia 11 tahun dengan keluhan nyeri tungkai kanan. Deskripsikan, sebutkan diagnosis radiologis dan diagnosis bandingnya.

Answer :

Teknik: Radiografi os femur kanan proyeksi AP dan lateral.

Deskripsi:

Tampak lesi litik geografik, ekspansil, zona transisi sempit di intramedulla mid-diafisis hingga metadiafisis distal os femur, dengan reaksi periosteal lamellated.

Kesimpulan:

Lesi osteolitik karakteristik maligna di os femur kanan, dapat sesuai dengan Ewing sarcoma, DD/ osteosarcoma.

Question #10

Pasien 20 tahun pasca KLL. Deskripsikan kelainan dan sebutkan diagnosis nya

Answer :

Teknik: Radiografi pelvis proyeksi AP.

Deskripsi:

Dislokasi sendi coxae kanan dengan pergeseran caput os femur kanan ke superolateral.

Tidak tampak fraktur.

Densitas tulang baik.

Sendi sakroiliaka dan coxae kiri baik.

Penebalan jaringan lunak regio hip joint kanan.

Kesimpulan:

- Dislokasi coxae kanan dengan pergeseran caput os femur kanan ke superolateral.
- Edema jaringan lunak regio hip joint kanan.

Question #11

Perempuan, 65 tahun, benjolan di payudara kanan

- A. Deskripsikan temuan pada gambar tersebut?
- B. Sebutkan kategori BIRADS nya?
- C. Sebutkan diagnosis kerja dan diagnosis bandingnya (bila ada)?

Answer :

Teknik: Mammografi bilateral proyeksi CC dan MLO.

Deskripsi:

Densitas mammae kanan dan kiri sesuai BIRADS b.

Tampak penebalan fokal kutis-subkutis di kuadran superolateral mammae kanan.

Tampak lesi berbentuk iregular dengan tepi berspikulasi di kuadran superolateral mammae kanan yang menyebabkan retraksi kulit di sekitarnya.

Tampak mikrokalsifikasi intralesi.

Tampak pembesaran KGB di aksila kanan.

Pada konfirmasi USG, didapatkan:

Lesi hipoekoik, bentuk iregular tepi sebagian berspikulasi, sejajar dengan kutis berukuran 3 x 2 x 5,6 cm di arah pukul 10.00 3 cm dari papilla mammae kanan, disertai gambaran kalsifikasi intralesi.

Tampak pula pembesaran KGB aksila kanan, tanpa fatty hilum dan korteks.

Kesimpulan:

- Lesi karakteristik maligna di mammae kanan, dapat sesuai dengan BIRADS 5
- Limfadenopati maligna di aksila kanan.

Question #12

Perempuan, 49 tahun, pasien sedang pemeriksaan USG payudara untuk deteksi kanker payudara dan

tidak memiliki keluhan saat pemeriksaan :

A. Deskripsikan temuan pada gambar tersebut?

B. Sebutkan kategori BIRADS nya?

Answer :

Teknik: Pemeriksaan ultrasonografi mammae kanan dengan transducer linear.

Deskripsi:

Tampak lesi anekoik berbentuk bulat, batas tegas, sejajar dengan kutis di jaringan fibroglandular mammae kanan di arah pukul 12.00, 1 cm dari papilla mammae kanan dengan posterior accoustic enhancement, berukuran 0,8 x 0,7 x 0,7 cm.

Kesimpulan:

Gambaran kista simpleks, dapat sesuai BIRADS 3.

Saran: follow-up USG mammae dalam 6 bulan.

Question #13

Pasien medical check up dengan keluhan terkadang batuk

- A. Deskripsi
- B. Kesimpulan
- C. Diagnosis banding jika ada

Answer :

Teknik: Radiografi toraks proyeksi PA

Deskripsi:

Jantung tidak membesar, CTR < 50%.

Opasitas heterogen hingga konsolidasi dengan fibrosis dan multipel cincin ekstasis di lapangan atas-tengah kedua paru yang menutupi bayangan aorta dan mediastinum superior.

Trakea deviasi minimal ke kanan.

Kedua hilus tidak menebal.

Fibrosis di lapangan atas-tengah-bawah kedua paru.

Tampak tenting pada hemidiafragma kanan.

Lengkung diafragma kiri licin.

Sinus kostofrenikus bilateral baik.

Tulang-tulang baik.

Kesimpulan:

Opasitas heterogen, bronkiektasis disertai fibrosis di kedua lapang paru, sesuai gambaran TBC paru lama aktif.

Question #14

Laki-laki dengan panuveitis.

A. Deskripsi

B. Kesimpulan

C. Diagnosis banding jika ada

Answer :

Teknik: Radiografi toraks proyeksi AP.

Deskripsi:

Jantung kesan tidak membesar.

Aorta baik.

Mediastinum superior melebar ke kanan (vaskular).

Trakhea di tengah.

Kedua hilus tampak menebal dengan tepi berlobulasi.

Corakan bronkovaskular tidak meningkat.

Multipel fibrosis di lapangan atas-tengah-bawah kedua paru

Kedua hemidiafragma tampak stenting

Kedua sinus kostofrenikus baik.

Tulang-tulang baik.

Kesimpulan:

- Penebalan hilus bilateral, DD/ limfadenopati.

- Fibrosis di kedua paru, sugestif infeksi lama.

Question #15

Perempuan dengan sklerosis sistemik. Dilakukan pemeriksaan CT scan karena sesak.

A. Deskripsi

B. Kesimpulan

C. Diagnosis banding

Answer :

Teknik: CT scan toraks non-kontras.

Deskripsi:

Ukuran jantung membesar, dengan rasio aorta : truncus pulmonalis 1,3.

Tampak multipel opasitas ground-glass dengan penebalan septa interlobular membentuk mosaic pattern di posterobasal kedua paru.

Kesimpulan:

- Interstitial lung disease

Question #16

Pasien screening TB

A. Deskripsi

B. Kesimpulan

C. Diagnosis banding jika ada

Answer :

Teknik: Radiografi toraks proyeksi AP.

Deskripsi:

Posisi asimetris.

Jantung kesan tidak membesar.

Aorta baik. Mediastinum superior tidak melebar.

Trakhea di tengah. Kedua hilus tidak menebal.

Corakan vaskular kedua paru tidak meningkat.

Massa di hemitoraks apikal kiri yang menyebabkan destruksi os costae 1,2,3 kiri, vertebra C7-T3.

Kesimpulan:

Sugestif gambaran pancoast tumor, DD/ tumor mediastinum anterior.

Question #17

LAKI-LAKI DENGAN SULIT BERKEMIH.

- a. Pemeriksaan apakah ini?
- b. Deskripsikan kelainan yang anda lihat!
- c. Apa diagnosis kerja anda?

Answer :

Teknik: Pemeriksaan retrograde vesicoureterografi dengan kontras water soluble.

Deskripsi:

Terpasang folley catheter melalui uretra.

Tampak kontras lancar mengisi uretra hingga vesica urinaria.

Tampak stenosis pada uretra pars bulbar dengan lumen tersempit 0,5 mm.

Tampak intravasasi kontras pada uretra pars membranacea.

Vesica urinaria tampak dilatasi ke kranial dengan gambaran pine tree appearance disertai multiple outpoching di posterolateral kiri.

Kesimpulan:

- Gambaran neurogenic bladder dengan cystitis.
- Divertikel vesica urinaria.
- Stenosis uretra pars bulbar.

Question #18

PASIEN 30 TAHUN, LAKI-LAKI HEMATURI

- a. Pemeriksaan apakah ini?
- b. Deskripsikan kelainan yang anda lihat!
- c. Apa diagnosis kerja anda?

Answer :

Teknik: Radiografi abdomen proyeksi AP.

Deskripsi:

Multipel opasitas tubular di pelvis minor, proyeksi ureter kanan.

Kesimpulan:

Ureterolithiasis kanan.